EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL : HOSPITAL DE SAN CARLOS N° EGRESO : 85483
SERVICIO : MEDICINA HSC
FECHA : 29-05-2024

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	: CEFERINO ALEJANDRO HERNANDEZ GUTIERREZ			RUN	: 4.932.736-6
F.Nac	: 26-08-1943	Edad	: 80 AÑOS, 9 MESES	Género	: Masculino
Dirección	: PRAT 839			Comuna	: SAN CARLOS
Previsión	: FONASA B	Teléfono	: 954011189		
Fecha Ingreso	: 2024-05-27	Fecha Egreso	: 29-05-2024	Causal	: MEDICA
Condición	: VIVO	Destino	: HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA	Derivación	:

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. J18.9-NEUMONIA, NO ESPECIFICADA

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

1. Insuficiencia respiratoria Aguda Tipo II resuelta
--> Neumonia adquirida en la comunidad en vias de resolucion
--> Smart COP: 4 ptos | PSI: 128 puntos, clase IV
2. LRA sobre ERC estadio III resuelta
3. SHH resuelto
--> Hipernatremia moderada en vias de correccion
4. Diabetes Mellitus tipo 2
--> Insulinorequiriente
--> Retinopatia Diabetica
5. Hipertension arterial
6. Delirium Activo
--> Demencia por enfermedad de Alzheimer
7. Limitacion funcional severa
--> Postrado e institucionalizado

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. J18.9-NEUMONIA, NO ESPECIFICADA (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)
2. E87.0-HIPEROSMOLARIDAD E HIPERNATREMIA. (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)
3. E10.7-DIABETES MELLITUS INSULINO DEPENDIENTE CON COMPL. MULTIPLES (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)
4. N17-INSUFICIENCIA RENAL AGUDA (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)
5. N18.3-ENFERMEDAD RENAL CRONICA,ESTADIO 3 (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)
6. F05.9-DELIRIO NO ESPECIFICADO (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)
7. Z73.6-PROBLEMAS RELACIONADOS CON LA LIMITACION DE LAS ACTIVIDADES (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)
8. J96.0-INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)
9. F03-DEMENCIA, NO ESPECIFICADA (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

Paciente de 78 años con antecedentes de DM2, (RD), HTA, ERC Estadio 3, Demencia, Postrado, institucionalizado. Ingresa a SU HSC el 24/05 a las 9:00 hrs am. Con historia de 1 semana de evolución previo a consulta con sintomas respiratorios principalmente tos, disnea y CEG. Al ingreso en SU se realizan laboratorios que destacan SHH: Glicemia 759 Osm 365, además elevación parámetros inflamatorios, PCR 357 GB 19500, Rx torax que evidencia foco de condensación bilateral, panel viral resp (-). Se inició manejo con BIC Insulina según protocolo, además de ceftriaxona empirico y broncodilatación. SHH en vias de resolucion, ultimos examenes : glic 262, lactato 1,4 PCR 201, Ur 177 ELP 154/3.5/120 GB 18600 Hb 12,3 Plt 330 mi pH 7.45 pCO2 36 pO2 68,8 Bic 23,4 DD 5619. Paciente ingresa a sala contenido, desorientado, hemodinámicamente estable 141/58 FC 75 lpm, sat 95% sin requerimientos de O2 suplementario, sin UMA. Panel viral + PCR covid negativo.

paciente evaluado por UPC previamente en contexto de SHH Dado co-morbilidades (principalmente demencia y postración), paciente no candidato a UPC. Paciente ingresado a sala medicina el dia 27/05/24 con cuadro de SHH resuelto, actualmente hemodinamia autosostenida, sin conflicto, normotenso, eucardico, eupneico, afebril, recibiendo antibioticos por NAC, ceftriaxona en 6to dia y azitromicina en 5to dia, paciente con delirium activo en manejo con haldol + quetiapina, clinicamente estable, menos ruidos respiratorios, sin UMA, diuresis presente en CUP. Paraclinicos estables, parametros inflamatorios en descenso, GSA en mejores condiciones que al ingreso. dado estabilidad clinica, cuadro de ingreso resuelto, y antibioticoterapia EV en su 6to dia, se envia a HODOM para completar tratamiento EV + KTR por 1 dia

PLAN DE MANEJO:

- Continuar manejo antibiotico en contexto de NAC, 1 dia restante de ceftriaxona EV en HODOM + azitromicina VO aun 2 dias, KTR 1 vez al dia durante visita por HODOM
- SHH resuelto, paciente con mal control metabolico, se realiza ajuste de dieta + educacion en medicacion, debe reiniciar NPH + aumentar ingesta de agua por via oral

INDICACIONES AL ALTA

1. Reposo Relativo, Cabecera en 30°
2. Régimen Hiposodico, hipoglicemico, Asistido
3. Aumentar ingesta de agua por via oral
4. Continuar con KTR
5. Retirar Foley mañana en HODOM
6. Ceftriaxona 2gr EV c/dia por 1 dia (hasta completar 7 dias 6/7)
7. Azitromicina 500mg vo c/dia por 2 dias hasta completar 7 dias (5/7)
8. Losartan 50mg 1 comp vo c/dia
9. Levotiroxina 75mcg c/dia de L-D
10. Atorvastatina 20mg c/noche vo
11. Quetiapina 25mg 1 comp vo c/noche
12. NPH 20Ui am - 10Ui pm, ajuste por APS
13. Salbutamol 2 puff c/4 hrs x AEC
14. B. de ipratropio 2 puff c/6 hrs x AEC
15. Continuar manejo en HODOM
16. Reanudar controles en APS una vez finalizada antibioticoterapia

EXÁMENES Y RESULTADOS

Laboratorios de ingreso a Sala medicina: glic 262, lactato 1,4 PCR 201, Ur 177 ELP 154/3.5/120 GB 18600 Hb 12,3 Plt 330 mi pH 7.45 pCO2 36 pO2 68,8 Bic 23,4 DD 5619
LAboratorios de egreso: Crea: 1.4 PCR: 40 Na: 151 K: 3.8 Cl: 122 PH: 7,43 pCO2: 28.4 PO2: 67.8 HCO3: 18.9

OBSERVACIONES:

Int. Perez
Dra. Jennifer Caraballo

Control en: 7 días en CONSULTORIO DE ORIGEN

CARABALLO DE HURTADO
JENNIFER DEL CARMEN
MEDICO TRATANTE
26251544-3

JEFE SERVICIO